

Cykl *Salkovskisa*

Bez mapy ERP staje się *ad hoc* — gasimy jeden objaw, inny wybucha. Mapa pokazuje sieć całego OCD z lotu ptaka.

CZAS: 30–45 min — głęboka inwentaryzacja PRZED budowaniem hierarchii ekspozycji

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1985, model poznawczy OCD); Foa i wsp. — Y-BOCS Symptom Checklist

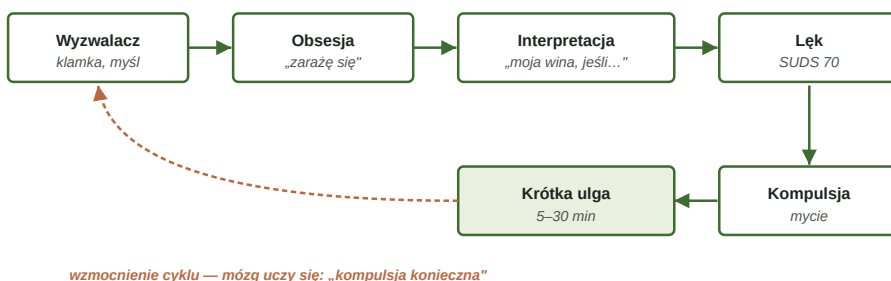
JAK UŻYWAĆ

Wypisz **cztery warstwy**: (1) *obsesje* — wszystkie natrętne myśli, obrazy, impulsy; (2) *interpretacje* — co ta myśl znaczy dla Ciebie; (3) *kompulsje* behawioralne i **mentalne**; (4) *unikanie* — czego nie robisz. Połącz strzałkami: wyzwalacz → obsesja → interpretacja → lęk → kompulsja → ulga → wzmocnienie. Mapa zasila **hierarchię ERP**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mapa OCD to **indywidualne sformułowanie przypadku** (ang. *case formulation*) według modelu poznawczego Salkovskisa (1985): cykl **obsesja → interpretacja → lęk → kompulsja → ulga → wzmocnienie**. Bez mapy pacjent z wieloma obsesjami *nie widzi wspólnego mianownika* i atakuje objawy chaotycznie. Pacjent z OCD ma zwykle *sieć powiązanych objawów*: jedne wzmacniają drugie, kompulsje mentalne ukrywają się przed świadomością, unikanie stało się „*normą*”. Najczęściej pomijane warstwy: **kompulsje mentalne** (bo „niewidoczne”) i **unikanie** (bo „*tak po prostu wolę*”). Mapa jest *fundamentem strategicznego planowania ERP* — pozwala atakować **cykl**, nie pojedyncze objawy.

01 ? Cykl Salkovskisa — schemat



02 ? Cztery warstwy do wypisania

1 · OBSESJE

Wszystkie natrętne myśli, obrazy, impulsy. Również te wstydlive. Treść *nie* ujawniana innym — tu zapisana całościowo.

2 · KOMPULSJE

Behawioralne i **mentalne**: mycie, sprawdzanie, układanie + neutralizowanie, modlitwy, analizowanie. Także *szukanie zapewnienia*.

3 · WYZWALACZE

Sytuacje, przedmioty, myśli, osoby, miejsca uruchamiające obsesję. **Mapa pól** pomaga w hierarchii.

4 · UNIKANIE

Czego **nie** robisz, żeby nie wyzwolić obsesji. Często niewidoczne — bo „*tak po prostu wolę*”.

WARSTWA

MOJE KONKRETNE TREŚCI

1 • Obsesje

*myśli, obrazy, impulsy*2a • Kompulsje
behawioralne*co robię*2b • Kompulsje
mentalne*co robię w głowie*

3 • Wyzwalacze

co uruchamia

4 • Unikanie

czego NIE robię

Klucz: Salkovskis (1985): „obsesja sama w sobie jest normalna — patologią jest interpretacja”. 90% populacji ma intruzje, ale tylko osoby z OCD interpretują je jako *znaczące i wymagające reakcji*. Mapa pokazuje, że **kompulsja przerywa naturalne wygaszenie** lęku — i karmi cykl. Najczęściej pomijane w mapowaniu: *kompulsje mentalne* i *unikanie*. Zapytaj siebie: „czego **NIE** robię z powodu OCD?” — to **znajduje unikanie**. Po wypełnieniu mapy: użyj danych do budowania *hierarchii ekspozycji*. Wracaj do mapy co kilka tygodni — wzorce mogą się zmieniać, OCD zmienia tematy.